Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Institut National de Santé Publique

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°157 /MVE-BDBV/18/10/2026

Date du rapport : 18 octobre 2026 Date de publication : 19 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 30 décès communautaires, ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces du Nord-Kivu (48 cas), de l'Ituri (42 cas) et du Haut-Uélé (7 cas). De plus, 11 autres décès de cas confirmés ont été enregistrés dans les CTE. Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24h.
- Un total de 500 nouveaux échantillons a été analysé ; 97 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 19,4% de positivité

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
9552	4 602	48,2 %	937	2 550	76,9%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

66 Zones de santé touchées sur 17 8(37,1%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

En date du 18 octobre 2026, 97 nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans trois provinces : **le Nord-Kivu (48 cas)**, **l'Ituri (42 cas)** et **le Haut-Uélé (7 cas).** Parmi ces cas, **30 décès communautaires** ont été rapportés. En outre, **11 décès confirmés** ont été enregistrés dans les CTE (6 en Ituri, 4 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé) portant **à 41 le nombre total de décès confirmés** notifiés au cours de la période

Par ailleurs, 20 patients (12 en Ituri, 7 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule **9 552 cas confirmés et 4 602 décès**, **soit une létalité de 48,2 %.** L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, avec **72,9 %** des cas confirmés cumulés et **43,3 %** des nouveaux cas confirmés notifiés au cours des dernières 24 heures

66 zones de santé sur 178 (37,1 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 18 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	42	6960	3 217	46,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	48	2084	1 176	56,4%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	7	415	177	42,7%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	0	73	25	34,2%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Nord Ubangi	0	2	1	50,0%	1/11 (9,1%)
Total	**97**	**9 552**	**4 602**	**48,2%**	**66/178 (37,1%)**

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 18 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6960**	**3217**	**46,2%**	**42**	**14**	**6**	**20**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	12	6	50,0%	1	0	0	0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	216	48	22,2%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1895	633	33,4%	14	4	1	5
Damas	41	10	24,4%	1	1	0	1
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	188	113	60,1%				0
Lita	309	156	50,5%				0
Logo	14	9	64,3%				0
Lolwa	36	9	25,0%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	74	32	43,2%	6	3	1	4
Mandima	337	170	50,4%	7	3	2	5
Mangala	382	164	42,9%	3	2	0	2
Mongbwalu	715	343	48,0%	2	1	0	1

Nia-Nia	331	191	57,7%	1	0	0	0
Nizi	827	298	36,0%				0
Nyankunde	134	41	30,6%	0	0	1	1
Rimba	19	5	26,3%				0
Rwampara	1167	403	34,5%	7	0	1	1
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**2084**	**1176**	**56,4%**	**48**	**16**	**4**	**20**
Beni	524	354	67,6%	18	13	0	13
Biena	24	8	33,3%	1	1	0	1
Butembo	312	188	60,3%	1	0	1	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	79	30	38,0%	3	0	1	1
Katwa	644	393	61,0%	5	1	0	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	44	21	47,7%				0
Lubero	35	14	40,0%				0
Mabalako	75	30	40,0%	1	0	0	0
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	16	5	31,3%	1	0	0	0
Masereka	39	13	33,3%				0
Musienene	152	71	46,7%	1	0	0	0
Mutwanga	24	5	20,8%			0	0
Oicha	52	23	44,2%	2	0	1	1
Vuhovi	55	16	29,1%	15	1	1	2
Haut-Uélé	**415**	**177**	**42,7%**	**7**	**0**	**1**	**1**
Boma Mangbetu	45	19	42,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	108	46	42,6%	2	0	0	0
Pawa	104	56	53,8%	2	0	1	1
Rungu	5	3	60,0%				0
Wamba	149	51	34,2%	3	0	0	0
Tshopo	**73**	**25**	**34,2%**	0	0	0	0
Bafwasende	17	2	11,8%				0
Kabondo	9	1	11,1%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	33	14	42,4%				0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0

Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Wapinda	2	1	50,0%				
Total	**9552**	**4602**	**48,2%**	**97**	**30**	**11**	**41**

***Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.**

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 18 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	101	7	108	18	7	80	0	25	4
Bas Uélé	118	1	119	13	0	105	1	13	0
Ituri	1 054	66	1 120	115	66	939	0	175	109
Nord-Kivu	1 703	77	1 780	168	75	1 535	2	243	114
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nord Ubangi	6	1	7	6	1	0	0	7	4
Tshopo	109	1	110	4	1	105	0	5	1
Total Général	**3 091**	**153**	**3 244**	**324**	**150**	**2 764**	**3**	**468**	**232**

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

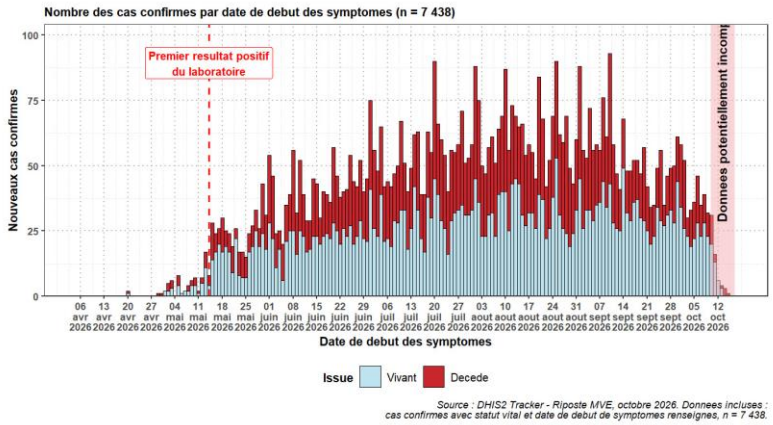
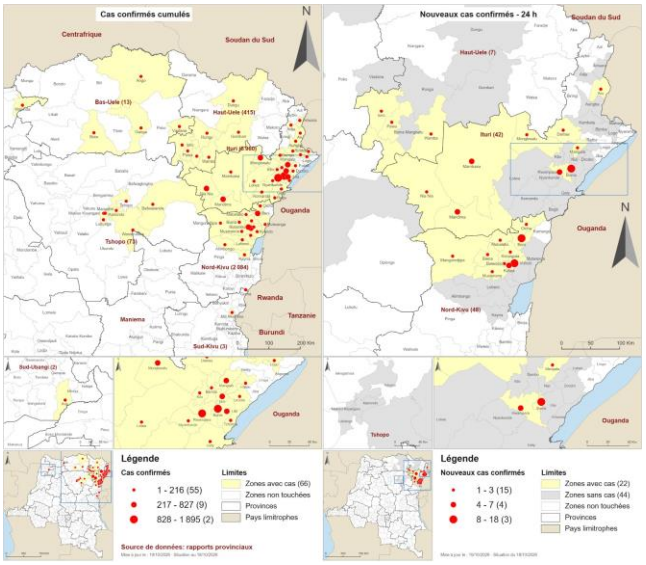


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

- Au cours de la journée du 18 octobre 2026, 3 244 alertes ont été notifiées dans les six provinces ayant transmis leurs données. Parmi elles, 3 241 (99,9 %) ont été vérifiées et classifiées, dont 474 (14,6 %) validées comme cas suspects et 2 767 (85,4 %) invalidées. Trois alertes restent à clarifier. Parmi les 474 cas suspects validés, 468 (98,7 %) ont été investigués, dont 232 (49,6 %) transférés vers les CT/CTE.
- Parmi les 32 744 contacts à suivre dans les sept provinces ayant transmis leurs données, 25 164 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 76,9 %, en baisse par rapport à la veille (80,0 %) et inférieur au seuil requis de 95,0 % (Tableau 4). Le suivi reste particulièrement faible en Ituri (69,9 %), notamment à Bunia (26,0 % ; 936/3 599), et au Nord-Kivu (78,6 %).

2.1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.1.3. Principales actions

- Pour la journée du 18 octobre 2026, 6 alertes ont été notifiées aux PoE/PoC des cinq provinces suivies : 5 en Ituri (1 au PoC Iga-Barrière et 4 au PoC Biakato Mayi) et 1 au Nord-Kivu (PoC PK5). Elles comprennent 3 alertes vivantes validées comme cas suspects (2 en Ituri et 1 au Nord-Kivu), dont 2 (66,7 %) ont été transférées vers une structure de soins, la suspecte de Biakato Mayi ayant refusé son transfert ; les 3 autres alertes de l'Ituri ont été invalidées à l'issue du dépistage secondaire et aucun corps sans vie n'a été intercepté.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 18 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,4% (61/62)	90,5% (19/21)	55,6% (5/9)	100,0% (18/18)	80,0% (8/10)	92,5% (111/120)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	ND	100%	80%	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	141 229	89 733	11 157	19 136	17 106	278 361
% des voyageurs screenés	97,8%	97,4%	98,9%	98,9%	98,8%	97,9%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,4%	97,4%	98,9%	98,9%	98,8%	97,7%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	97,4%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%
Nombre d'alertes notifiées	5	1	0	0	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	1	0	0	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	50,0%	100,0%	NA	NA	NA	66,7%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	NA	NA	100,0%

2.1.4. Défis

- **En Ituri**, l'insuffisance de mobilité pour la supervision dans les ZS de Rwampara, Nizi et Bunia, le retard de paiement des prestataires et le besoin d'une ambulance pour desservir les PoC de la ZS de Mandima persistent ; la mobilité des voyageurs au PoC de Mudzi Bala a été perturbée par la manifestation des chauffeurs et le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel en raison de l'insécurité. Au Nord-Kivu, la complétude recule à 90,5 % (19/21) ; le PoC de Butuhe demeure fermé depuis l'incident sécuritaire du 26 septembre 2026 et le PoE de Kyavinyonge n'a pas rapporté ; la menace sécuritaire sur l'axe Butembo, la rupture de consommables et l'absence d'ambulance dédiée aux PoC persistent., Kalundu Port SNCC et Baraka ne disposent pas de dispositif d'isolement. Au Haut-Uélé, le PoE de Doko (absence de vol programmé) et le PoC de Gossamu (mauvaise connexion) n'ont pas rapporté. Au Bas-Uélé, les prestataires du PoC PK12 Isiro sont en grève pour non-paiement, et les services du PNHF, la formation et la motivation des prestataires, l'approvisionnement en eau, la mobilité, la connectivité et la digitalisation des PoE/PoC font défaut.

2.2.Laboratoire

2.2.1. Principales actions

- **Ituri : 42 nouveaux résultats positifs** (28 vivants et 14 décès) sur 202 échantillons reçus et analysés (positivité : 20,8%).
- **Nord-Kivu : 48 nouveaux résultats positifs** (32 vivants et 16 décès) sur 247 échantillons reçus et analysés (positivité : 19,4%).
- **Haut-Uélé : 7 nouveaux résultats positifs** (7 vivants et 0 décès) sur 28 échantillons reçus et analysés (positivité : 25%).
- **Tshopo : Aucun nouveau résultat positif** sur 11 nouveaux échantillons reçus et analysés tous sont révélés négatifs
- **Bas Uélé : 12 nouveaux échantillons reçus au laboratoire de Buta** dont 4 nouveaux échantillons ont été envoyés au laboratoire Isiro tous sont revenus négatifs.
-

2.3. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.3.1. Principales actions

- **Ituri** : 20 rings ont été ouverts sur 26 (76,9 %), 17 ménages décontaminés sur 29 (58,6 %) et 6 FOSA décontaminées sur 6 (100,0 %).44 EDS ont été réalisés sur 76 alertes EDS, (57,9 %) et 51 corps swabés sur 67 (76,1 %)
- **Tshopo** : 7 ESS ont été suivis dans 4 ZS et 72 prestataires briefés sur les précautions standards, le triage et le screening ; le CS Neema a été décontaminé autour du 72e cas confirmé et 10 PPL y ont été évalués (5 à

haut risque, 3 à risque intermédiaire et 2 à risque faible) ; 1 ring a été ouvert à Makiso-Kisangani. Trois alertes EDS reçues.

- **Nord-Kivu** : 6 rings ont été ouverts sur 16 (37,5 %), 6 ESS décontaminés sur 8 (75,0 %) et 5 ménages sur 27 (18,5 %), aucun des 5 ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; aucun PPL n'a été infecté parmi les 14 cas confirmés de référence. Sur 55 alertes EDS reçues et 47 reports de la veille, 62 EDS ont été réalisés et 55 corps swabés, sans échec de prélèvement.
- **Bas-Uélé** : 9 ESS ont été suivis dans 4 ZS (Buta 4/4, Ganga 1/1, Poko 1/1 et Viadana 3/3) et, à Ganga, 37 prestataires sur 39 (94,8 %), 14 hygiénistes et 5 superviseurs PCI ont été briefés ; les DLM de l'HGR de Buta (13/13), du CS Makala (3/3), du CM Mangindanginda (1/1) et du CS du Congo (1/1) sont fonctionnels.

2.3.2. Défis

- **En Ituri**, 6 rings sur 26 restent à ouvrir, 12 ménages sur 29 n'ont pas été décontaminés, 21 EDS ont échoué et 16 corps sur 67 (23,9 %) n'ont pas pu être swabés.
- **Au Nord-Kivu**, les équipes de décontamination ont été agressées dans les AS de Butsili et de Butanuka (ZS de Beni) ; 10 rings sur 16 restent à ouvrir, 22 ménages sur 27 n'ont pas été décontaminés, aucun ménage n'a été doté en kits (0/5) et 40 EDS restent reportés au lendemain. À la Tshopo, l'insuffisance d'intrants et de matériels PCI et de PPL formés en PCI persiste, et l'absence des familles empêche la réalisation des swabs. Au Bas-Uélé, 16 ESS prioritaires sur 20 n'ont pas de triage fonctionnel, aucun ne dispose de matelas garnis, 17 sur 20 n'ont pas de stockage d'eau couvrant 72 heures, les zones de gestion des déchets et les latrines hygiéniques font défaut et la remontée des alertes de décès communautaires reste faible.

2.4. Prise en charge holistique

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 104 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 68 sorties : 12 guérisons ainsi : 429 patients sont hospitalisés soit un taux d'occupation de 41 %, dont 59 malades critiques ; 31 patients ont été évacués par ambulance, 410 patients sur 418 (98 %) ont reçu des repas chauds et 100 poches de sang ont été réceptionnées du CNTS de Kinshasa (103 en stock).
- **Au Nord-Kivu**, 74 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 95 sorties : 7 guérisons (2 à Katwa et 5 à Butembo). Ainsi, 450 patients sont hospitalisés dont 62 enfants de moins de 5 ans) parmi eux 2 malades sont en étant critiques, pour un taux d'occupation global des CTE/CT de 87,6 % (359/410), de 93,8 % pour les suspects (180/192) et de 82,1 % pour les confirmés (179/218) ; 91 patients (20,2 %) sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT. 9 courses d'ambulance ont été réalisées avec succès (7 ambulances sur 14 utilisées) et 181 confirmés, 216 suspects, 427 PPL et 197 accompagnants ont reçu des repas chauds.
- **À la Tshopo**, 2 nouvelles admissions de suspects ont été enregistrées au CTE de Météo contre 3 sorties et 1 patiente déclarée guérie Ainsi, 16 patients sont hospitalisés pour 36 lits, soit un taux d'occupation de 44,4 % ; 7 patients sont perdus de vue. Depuis le début, 45 cas confirmés ont reçu le traitement expérimental (3 MBP134 et 42 Remdesivir) et 481 personnes la prophylaxie post-exposition.

2.4.2. Défis

- **En Ituri**, le faible capacité d'accueil de certains CTE/CT (Kilo, Lolwa et Biakato), la prise en charge de 59 malades critiques, la quantité de sang insuffisante au regard des besoins des CTE et des hôpitaux, l'absence d'alimentation pour 8 patients de la ZS de Mandima (CT Mandima et CT Makeke) et le faible rapportage des mouvements d'ambulances (18/33) demeurent préoccupants.
- **Au Nord-Kivu**, les lits des suspects sont saturés à 93,8 % (180/192), 20,2 % des patients hospitalisés (91/450) sont pris en charge hors CTE/CT et la complétude des données n'est que de 71 % (Beni, Musienene et Kalunguta manquants).
- **À la Tshopo**, l'absence de soutien alimentaire et nutritionnel au CT de Bafwasende et le nombre élevé de perdus de vue (7, dont 6 confirmés de Bafwasende et un motard confirmé qui erre dans la communauté) restent préoccupants.
- **Au Bas-Uélé**, le retard dans la mise en place du CTE normé, encore en construction à l'HGR de Buta, l'absence d'ambulance, la non-prise en compte du soutien nutritionnel des suspects isolés dans les ESS et le retard d'accompagnement psychosocial des 3 confirmés demeurent des défis majeurs.

2.5. Vaccination

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri,** la vaccination des PPL par l'Ervebo et les activités de recherche se poursuivent (essais Partners, EBO-PEP et Oracle, préparatifs du projet TUMAINI) ; 57 membres de l'équipe-cadre, infirmiers titulaires et représentants des PRECODESA de la ZS de Rwampara ont été briefés sur l'essai clinique du vaccin contre le virus Bundibugyo, réservé aux nouveaux contacts des cas confirmés. Le cumul des PPL vaccinés reste de 1 260, les données du jour n'ayant pas été transmises.
- **Au Nord-Kivu**, le cumul des PPL vaccinés dans la ZS de Beni atteint 322 sur une cible de 7 105 (4,5 %) ; la vaccination des PPL de l'AS Mabakanga s'est poursuivie sous supervision et la disponibilité des dispositifs de transport du vaccin (ARKTEK) est suivie avec l'OMS. Au Bas-Uélé, 500 doses de vaccin Ervebo ont été

réceptionnées, le déploiement d'une équipe d'appui à la vaccination compassionnelle dans la ZS d'Ango est en préparation et la couverture atteint 11,4 % de la cible (1 500/13 202), dont 21,6 % à Buta et 20,5 % à Ganga.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, la cible des PPL et des TPL reste à redéfinir pour le calcul de la couverture vaccinale (1 120 vaccinés pour une cible provisoire de 1 000).
- **Au Bas-Uélé**, la mise en marche des UCC n'est pas effective, les vaccins ne sont pas disponibles en quantité suffisante et les fonds de la vaccination restent attendus ; à la Tshopo, un écart de 551 vaccinés persiste entre les bases Excel et DHIS2 et la ZS de Bafwasende n'a pas rapporté depuis quatre jours ; au Nord-Kivu, l'équipe de vaccination manque de moyens de mobilité (2 véhicules) et de 3 tentes de petit format, et les dispositifs de transport du vaccin (ARKTEK) restent à confirmer avec l'OMS.

2.6. Continuité des Soins

2.6.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, 5 enfants séparés sur 5 ont été pris en charge à la crèche, 16 nourrissons séparés ou orphelins sur 16 sont sous substitut de lait maternel, 1 enfant malnutri sur 1 a été pris en charge, 8 confirmés instables ont bénéficié de régimes spécifiques et 36 ménages de patients ont reçu des vivres.
- **À la Tshopo**, un 22e prestataire de première ligne a été confirmé au CS Neema (Makiso-Kisangani), où l'évaluation a relevé l'absence de zone de triage, d'EPI et d'incinérateur fonctionnel, 2 agents vaccinés sur 16 (12,5 %) et un seul infirmier formé sur la MVE ; le CM État-major de la Prison centrale a été évalué et son plan de redressement élaboré, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que des guéris présentant des complications à l'HGR de Makiso-Kisangani se poursuit.
- **Au Bas-Uélé**, l'évaluation de l'HGR de Ganga montre une baisse du taux d'utilisation des services, de 29,5 % en juin à 20,3 % en septembre 2026, pour une norme de 60 %, traduisant une faible fréquentation ou un recours tardif aux soins.
- **En Ituri**, 75 enfants ont bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle par LNPE/SLM : 11 sur 11 au CTE, 4 sur 4 à la crèche et 60 sur 60 dans la communauté.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 20 347 visites à domicile ont touché 72 604 personnes ; 365 causeries éducatives ont réuni 10 167 personnes, 82 sensibilisations de masse ont touché 3 019 personnes, 9 débats communautaires ont réunis 345 personnes et 8 plaidoyers ont été organisés en faveur de 30 autorités religieuses et APA (Rwampara et Komanda) ; à Mandima, 276 élèves et enseignants de l'institut Biakato ont été sensibilisés sur la prévention de la MVE et la remontée des alertes en milieu scolaire. Au total, 304 alertes communautaires, dont 92 décès, ont été notifiées ; 49 feedbacks sur 65 (75,4 %) et 5 incidents sur 7 (71,4 %) ont été résolus dans les 48 heures. La CREC a facilité le pré-listage de 216 contacts, la décontamination de 7 ménages sur 7, la réalisation de 11 EDS sur 11, l'annonce de 17 résultats positifs sur 18 et le transfert de 33 suspects sur 33 au CTE ; la complétude des rapports CREC reste faible (10/28 ZS, 36 %).
- **Au Nord-Kivu**, 18 328 visites à domicile ont touché 59 822 personnes, 179 causeries éducatives ont été organisés pour 6 119 personnes, 120 communications de masse 7 889 personnes et 4 briefings 180 personnes ; 562 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues (86,5 %), 9 feedbacks sur 13 (69,2 %) et 3 incidents sur 8 (37,5 %) ont été résolus dans les 48 heures, les 5 refus de transfert au CTE de Butembo restant non résolus, et 3 467 personnes sur 4 750 (73,0 %) ont été engagées dans les actions communautaires. Un dialogue sur les résistances a réuni 30 chefs locaux de l'AS Kasanga (Beni) et 44 membres de l'équipe d'intervention rapide de Beni ont été formés.
- **À la Tshopo**, la CREC a appuyé la décharge de la nouvelle guérie au CTE de Météo et les activités autour du cas n°72 dans l'AS Neema (listage des contacts, adhésion des PPL à la prophylaxie et décontamination) ; les sensibilisations dans les confessions religieuses de Kisangani, Bafwasende et Wanie-Rukula ont touché environ 44 153 personnes, 2 refus sur 2 ont été brisés et 2 feedbacks résolus. Au Bas-Uélé, 539 visites à domicile ont touché 1 449 personnes, 2 causeries éducatives 38 personnes et 6 sensibilisations de masse 1 714 personnes à Ganga, Viadana et Likati, et 5 feedbacks sur 5 ont été résolus à Ganga.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **Ituri**, 13 cas confirmés sur 27 (48,1 %), 93 confirmés en cours de suivi sur 156 (59,6 %), 38 nouveaux suspects sur 104 (36,5 %) et 108 suspects en cours de suivi sur 146 (74,0 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 213 accompagnants et 63 PPL, suivi 14 guéris sur 19 (73,7 %) en communauté et 13 enfants sur 13 en crèche, accompagné 8 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 13, réinséré 5 guéris sur 12 et annoncé 37 résultats, dont 13 positifs ; 44 enfants sont suivis et la formation de 12 psychologues et APS/TPS (8 hommes et 4 femmes) a démarré à Mandima.
- **À la Tshopo**, 3 cas confirmés en cours de suivi sur 3, 2 nouveaux suspects sur 2 et 5 suspects en cours de suivi sur 5 (100 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 2 ménages ont été accompagnés pour les actions

de santé publique, 6 PPL soutenus, 1 résistance sur 1 brisée et 1 résultat négatif annoncé, et les APS de Bafwasende ont été coachés.

- **Au Bas-Uélé,** 73 personnes (67 hommes et 6 femmes) ont participé aux séances de psychoéducation sur la MVE, les VBG et la protection de l'enfant dans la communauté et aux points de contrôle ; aucun autre indicateur SMSPS n'a été rapporté.

2.8.2. Défis

- **En Ituri**, seules 14 ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et seuls 13 des 27 derniers cas confirmés (48,1 %) ont été pris en charge ; le déploiement des psychologues et APS/TPS formés est attendu après la formation.
- **Au Bas-Uélé**, l'accompagnement psychosocial des 3 confirmés accuse du retard ; à la Tshopo, les APS de Wanie-Rukula restent à former.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions.

- Assurer la mobilité de toutes les équipes de terrain dans les provinces touchées ; au Nord-Kivu, la construction des cabanes au PoC PK5 et de la passerelle des voyageurs à l'aéroport de Beni se poursuit avec l'appui de l'OIM ; au Bas-Uélé, la construction du CTE de l'HGR de Buta et la réhabilitation des bureaux de la DPS se poursuivent et les intrants destinés aux ZS en préparation sont en cours de colisage.

2.10. Sécurité

2.11. Principales actions.

- À la Tshopo, l'ordre public a été rétabli au CM La Grâce (Beni) face à la résistance d'un cas suspect et des équipes de décontamination ont été agressées dans les AS de Butsili et de Butanuka. À la Tshopo, les menaces contre les équipes empêchent les investigations autour des cas 65 à 70 à Bafwasende ; en Ituri, le PoC d'Avakubi demeure non fonctionnel en raison de l'insécurité.

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- Au Nord-Kivu, 40 leaders communautaires et agents des radios (31 hommes et 9 femmes) ont été formés sur la PSEA/HS à Butembo et à Katwa, et 406 personnes ont été sensibilisées sur le signalement via le 495555/151 à Beni, Katwa, Nyiragongo, Kalunguta et Mabalako ; à la Tshopo, le plan de travail bimensuel du pilier PEAHS a été élaboré.

2.12.2. Défis

- Au niveau national, la couverture des zones touchées reste faible (56 ZS sur 151 avec des activités PSEA, soit 37,1 %), les supports de visibilité sont insuffisants et l'efficacité des CBCM est faible ; à la Tshopo, les outils de collecte et la mobilité des points focaux font défaut.

MESSAGES CLES

- Au cours des dernières 24 heures, 468 cas suspects sur 474 (98,7 %) ont été investigués dans les provinces ayant transmis leurs données. Toutefois, 6 cas suspects restent non investigués en Ituri (5 à Nyankunde et 1 à Mongbwalu). Par ailleurs, le taux de suivi des contacts a reculé, passant de 80,0 % la veille à 76,9 %, et demeure inférieur au seuil requis de 95,0 %. Cette situation nécessite un renforcement de la surveillance épidémiologique et du suivi des contacts afin de limiter les risques de transmission communautaire. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider les actions PCI et CREC au niveau des communautés tout en offrant des soins de qualité dans les structures de prise en charge dédiées avec des capacités d'accueil adéquates

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP
Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager
Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations
Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction
Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard
Dr KATUSI BISELENGE Jules
Madame MAYELE AFUA Marie
Dr DIUR MANANASHI Floryan
Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd